

1. Datos del paciente

ID Paciente	P010
NHC	NHC-2023-011502
Nombre completo	Sara Molina Grau
Sexo	Mujer
Fecha nacimiento	11/04/1995
Edad	31 años
DNI	53.198.207-B
Teléfono	633 412 567
Municipio	Castelló de la Plana
Médico responsable	Dra. Elena Martínez Roca
Especialidad	Psiquiatría

2. Antecedentes personales

- Trastorno de estrés postraumático crónico (diagnóstico 2020, CIE-10: F43.1)
- Trastorno de personalidad límite — inestabilidad emocional (diagnóstico 2021, CIE-10: F60.3)
- Autolesiones no suicidas recurrentes (cortes superficiales en antebrazo), último episodio hace 3 meses
- Dos tentativas autolíticas previas por ingesta medicamentosa (2019 y 2022)
- Trastorno de la conducta alimentaria no especificado en remisión (2018–2020)
- Alergia a metamizol

Antecedentes familiares: Madre: trastorno depresivo recurrente. Padre: trastorno de personalidad antisocial (no diagnosticado formalmente, según informes sociales). Historia de maltrato intrafamiliar en la infancia documentada por servicios sociales.

3. Historia clínica actual

Paciente de 31 años con diagnóstico de trastorno de estrés postraumático crónico secundario a maltrato físico y psicológico intrafamiliar durante la infancia y adolescencia (de los 6 a los 16 años), y diagnóstico comórbido de trastorno de personalidad límite. Los síntomas de TEPT incluyen flashbacks intrusivos recurrentes (2-3 por semana), pesadillas nocturnas con contenido traumático (3-4 noches/semana), hipervigilancia constante en espacios públicos, respuesta de sobresalto exagerada y evitación de situaciones que le recuerdan al trauma (conflictos interpersonales, tonos de voz elevados, espacios cerrados con hombres desconocidos). Presenta inestabilidad afectiva intensa con cambios de ánimo rápidos, sentimientos crónicos de vacío, patrón de relaciones interpersonales inestable e intenso con idealización y devaluación alternantes, e impulsividad en forma de atracones alimentarios y gastos impulsivos. Las autolesiones (cortes superficiales en antebrazo izquierdo) se producen como mecanismo de regulación emocional ante estados disociativos; último episodio hace 3 meses. Las dos tentativas autolíticas previas ocurrieron en contexto de rupturas sentimentales (2019: ingesta de 20 comprimidos de paracetamol; 2022: ingesta de 15 comprimidos de diazepam). Actualmente niega ideación autolítica activa pero reconoce pensamientos pasivos de muerte en momentos de crisis emocional intensa. Está en programa de terapia dialéctico-conductual (DBT) grupal desde hace 8 meses con mejoría parcial en regulación emocional. Vive sola en piso de alquiler. Trabaja como dependienta a tiempo parcial. Red social reducida a una amiga y su terapeuta.

4. Exploración

Aspecto general	Consciente, orientada. Vestimenta oscura. Cicatrices antiguas visibles en antebrazo izquierdo (lineales, paralelas, en distintos estadios de cicatrización)
Psicomotricidad	Normal. Sin agitación. Se observa hipervigilancia: mira repetidamente hacia la puerta
Estado de ánimo	Disfórico con componente ansioso. Afecto lábil: llanto en dos ocasiones durante la entrevista al abordar contenido traumático
Pensamiento	Curso normal. Contenido con rumiaciones sobre experiencias traumáticas. Ideas de autodesprecio. Niega ideación autolítica activa actual
Sensopercepción	Refiere episodios disociativos breves (despersonalización) en situaciones de estrés intenso, duración de minutos. Sin alucinaciones
Cognición	Atención disminuida por hipervigilancia. Concentración irregular. Memoria conservada salvo lagunas en período traumático
Riesgo autolítico	Riesgo moderado: dos tentativas previas, autolesiones, ideación pasiva de muerte intermitente. Sin plan actual
Peso / Talla / IMC	55 kg · 162 cm · 21,0 kg/m ²
Tensión arterial	108/68 mmHg
Frecuencia cardíaca	92 lpm, rítmica (taquicardia situacional por ansiedad)

5. Tratamiento actual

Fármaco	Posología
Sertralina 150 mg	1 comp. en desayuno (ISRS para TEPT y regulación emocional)
Prazosina 2 mg	1 comp. en cena (reducción de pesadillas traumáticas)
Quetiapina 25 mg	1 comp. en cena si insomnio o agitación (uso a demanda, máximo 3 noches/semana)
Hydroxyzina 25 mg	1 comp. si crisis de ansiedad aguda (alternativa a benzodiacepinas)

6. Resultados de laboratorio

Parámetro	Resultado	Ref.	Estado	Previo
Hemograma	Normal	—	Normal	Normal
Ferritina	18 ng/mL	20–200	Bajo	22 ng/mL
Hierro sérico	52 mcg/dL	60–170	Bajo	58 mcg/dL
Vit. D	14 ng/mL	30–100	Bajo	18 ng/mL
TSH	2,8 mU/L	0,4–4,0	Normal	3,1 mU/L
Glucosa	82 mg/dL	70–110	Normal	86 mg/dL
Perfil hepático	Normal	—	Normal	Normal

7. Plan de actuación

1. Mantener sertralina 150 mg. Valorar aumento a 200 mg si persisten síntomas de TEPT en próxima revisión
2. Continuar prazosina 2 mg; si pesadillas persisten, titular a 4 mg
3. Suplementar: hierro oral 80 mg/día con vitamina C + vitamina D 2.000 UI/día
4. Continuar programa DBT grupal semanal + terapia individual quincenal con enfoque en procesamiento traumático (EMDR planificado para fase 2)

5. Plan de seguridad actualizado: identificación de señales de alerta, cadena de llamada (terapeuta → amiga → 024), kit de crisis con habilidades TIPP
6. Evitar prescripción de benzodiacepinas por riesgo en contexto de impulsividad y tentativas previas
7. Control analítico en 2 meses: ferritina, hierro, vitamina D
8. Revisión presencial en 4 semanas. Contacto telefónico intermedio en 2 semanas

AVISO: Todos los datos de este documento son completamente ficticios. Generado para el TFG: Sistema RAG de apoyo en salud mental.